



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رشا محمد ابراهيم محمد

العنوان : 33 شارع سيدى
الانصارى

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم البطاقة : 28104242100081 رقم التليفون : 01129789919

العمر(تاريخ الميلاد) : 24-04-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رشا محمد ابراهيم محمد National ID: 28104242100081	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

رشا
محمد ابراهيم محمد
٣٣ ش سيدى الانصارى
الجيزة - الجيزة

١٩٨١/٠١/٠١

٢٨١٠٤٢٤٢١٠٠٠

J00183245

National ID - Front
[J00079540]

٢٠٢٢/٠٩ ٢٨١٠٤٢٤٢١٠٠٠٨١
ربة منزل
أنثى مسلمة أرملة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/٠٩ ١



PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: رشا محمد انور احمد محمد	Age: 45 years	Sex: female
Request type: ميلدرة	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.:964B-2026	
Department: صحة مرآه	Date of result:19/9/2026	
Referred by: د.ريهام راضي	Date of biopsy:9/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number:28104242100081	
Clinical diagnosis: Right breast mass		

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against GATA3-ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing malignant tumor. Tumor form syncytial of markedly anaplastic cells infiltrating among marled lymphocytic infiltrate. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result:

Neoplastic cells showed positive GATA3

ER: Moderate nuclear staining in 30% of tumor cells (Allred Score 5/8).

PR: Weak nuclear staining in 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: No membranous staining of tumor cells (score 0)Null.

Ki67: Positive nuclear staining in 90% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive mammary carcinoma with meduallry features, Grade III.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Mes

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: رشا محمد ابراهيم محمد	Age: 45 years	Sex: female
Request type: مبداءه	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 964B-2026	
Department: صحة مصر	Date of result: 19/9/2026	
Referred by: د/يحيى راضي	Date of biopsy: 9/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number: 28104242100081	
Clinical diagnosis: Right breast mass		

Gross pathology:

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against GATA3-ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing malignant tumor. Tumor form syncytial of markedly anaplastic cells infiltrating among marled lymphocytic infiltrate. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result:

Neoplastic cells showed positive GATA3

ER: Moderate nuclear staining in 30% of tumor cells (Allred Score 5/8).

PR: Weak nuclear staining in 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: No membranous staining of tumor cells (score 0)Null.

Ki67: Positive nuclear staining in 90% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, Tru-cut biopsy:

Invasive mammary carcinoma with medullary features, Grade III.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Mos

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

اسم المريض بالإحطارية: Rasha Mohamed Ibrahim	كود المريض: 99177
تاريخ الفحص: 2026/09/09 09:09:45 AM	السن: 45 سنة 4 أشهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 45 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Heterogenous dense fibro glandular parenchyma (ACR density C).
- UOQ high dense oval mass with indistinct margins associated with anterior architectural distortion.
- Multiple circumscribed equal dense masses.
- Ultrasound revealed UOQ irregular hypoechoic non parallel mass lesion measures about 36x28mm located at 9 ° clock zone b, being about 5mm from overlying associated with anterior area of non mass measuring 12x10mm and allover process being about 30mm from the nipple .
- Multiple circumscribed thin wall anechoic variable sized clear cystic masses.
- Prominent retroareolar ducts.
- Few less than 3 enlarged axillary lymph nodes at level I with diffuse cortical thickening 3.5mm.

Left breast:

- Heterogenous dense fibro glandular parenchyma (ACR density C).
- Multiple circumscribed equal dense masses.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple circumscribed thin wall anechoic variable sized clear cystic masses.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- ✓ Right breast: Right UOQ highly suspicious mass with anterior non mass lesion as described. For tru cut biopsy and contrast study. (BIRADS-4c)
- ✓ Left breast: left breast fibrocystic changes (BIRADS 2).
- ✓ Biopsy was taken at the same sitting for histopathological assessment.

Much obliged,
Dr. Reham Rady, FRCR, FRCR

اسم المريض بالإنجليزية: Rasha Mohamed Ibrahim	كود المريض: 99177
تاريخ الترخيد: 2026/09/09 09:09:45 AM	السن: ٤٥ سنة ٢ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 45 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Heterogenous dense fibro glandular parenchyma (ACR density C).
- UOQ high dense oval mass with indistinct margins associated with anterior architectural distortion.
- Multiple circumscribed equal dense masses.
- Ultrasound revealed UOQ irregular hypoechoic non parallel mass lesion measures about 36x28mm located at 9 ° clock zone b, being about 5mm from overlying associated with anterior area of non mass measuring 12x10mm and allover process being about 30mm from the nipple.
- Multiple circumscribed thin wall anechoic variable sized clear cystic masses.

- Prominent retroareolar ducts.

- Few less than 3 enlarged axillary lymph nodes at level I with diffuse cortical thickening 3.5mm.

Left breast:

- Heterogenous dense fibro glandular parenchyma (ACR density C).
- Multiple circumscribed equal dense masses.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple circumscribed thin wall anechoic variable sized clear cystic masses.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- ✓ Right breast: Right UOQ highly suspicious mass with anterior non mass lesion as described. For tru cut biopsy and contrast study. (BIRADS-4c)

- ✓ Left breast: left breast fibrocystic changes (BIRADS 2).

- ✓ Biopsy was taken at the same sitting for histopathological assessment.

Much obliged,

Dr. Reham Rady, FRCR, FRCR